
Examen blanc de résidanat

Épreuve 1

09 Novembre 2023

Cette épreuve comprends 93 QCM et 22 cas cliniques

I- Partie A : QCM

Veillez inscrire les réponses aux QCM dans la grille réservée aux QCM

1. l'épilepsie myoclonique juvénile est caractérisé par :

- a- Un début chez l'adolescent
- b- Des myoclonies au réveil
- c- L'association à des crises tonico-cloniques
- d- Une évolution favorable sous traitement
- e- Est secondaire à une dysplasie corticale

2. l'épilepsie à paroxysme rolandique ou à pointes centro-temporales est caractérisée par :

- a- La fréquence des crises oro-faciales
- b- Un pronostic favorable
- c- Des anomalies spécifiques à l'imagerie cérébrale
- d- Un EEG qui montre des pointes bi-phasiques centro-temporales bilatérales
- e- Sa résistance aux antiépileptiques

3. Parmi les suivants, quels sont les critères diagnostiques définissant le syndrome de West

- a- Spasmes épileptiques
- b- Arrêt du développement psychomoteur
- c- Microcéphalie
- d- Aspect d'hypsarythmie à l'EEG
- e- Survenant après l'âge de 18 mois

4. Une crise focale visuelle :

- a- Est liée à une décharge occipitale controlatérale
- b- Intéresse un hémichamps visuel
- c- Se manifeste par des macropsies
- d- S'accompagne souvent d'une baisse de l'acuité visuelle
- e- S'associe à une perte de connaissance

5. Une crise à début généralisé motrice tonico-clonique se caractérise par :

- a- La présence systématique d'un témoin
- b- Une chute progressive et lente
- c- Une durée brève 2-3min
- d- Une apnée et cyanose durant la phase tonique
- e- Une contracture des muscles des 4 membres en flexion puis en extension

6. Une absence typique se manifeste par :

- a- Des clonies des paupières
- b- Une chute brutale et traumatisante
- c- Une durée inférieure à 25 secondes
- d- Un ralentissement à l'EEG inter-critique
- e- Des automatismes gestuels simples

7. les médicaments suivants peuvent être indiqués dans le traitement d'une crise d'asthme :

- A- Théophylline par voie orale
- B- Un anticholinergique en nébulisation
- C- terbutaline en nébulisation
- D- montelukast (singulier)
- E- salmeterol (serevent)

8. Chez l'asthmatique, les corticoïdes inhalées en aérosol-doseur :

- A- sont susceptibles d'engendrer des Complications locales
- B- sont anti inflammatoires
- C- sont administrés en traitement de fond
- D- sont bronchodilatateurs
- E- sont prescrits uniquement en cas d'asthme aigu grave

9. Chez un patient asthmatique sévère, la survenue d'un asthme aigu grave peut être dû à :

- A- une prise de sédatifs
- B- un usage excessif de β_2 adrénergiques inhalés
- C- des facteurs psychologiques
- D- un arrêt brutal d'une corticothérapie inhalée
- E- un accident d'immunothérapie allergénique

10. Le test de provocation bronchique non spécifique est réalisé chez l'asthmatique pour :

- A- Confirmer la réversibilité
- B- Déterminer le type de déficit ventilatoire
- C- Mettre en évidence la présence d'une hyperréactivité bronchique
- D- Confirmer l'étiologie allergique de l'asthme
- E- Différencier entre asthme et BPCO

11. Les éléments cliniques en faveur de l'asthme aigu grave sont :

- A- une fréquence respiratoire : 35cycles/mn
- B- une fréquence cardiaque : 128 /mn
- C- une distension thoracique
- D- un DEP : 20% de la valeur théorique
- E- des sibilants audibles à l'auscultation

12. La contamination hydatique de l'homme se fait par :

- A- Ingestion de légumes souillés par les excréments du chien infesté
- B- Ingestion de viande de mouton infesté
- C- Inhalation de tænia échinocoque
- D- Contact avec des moutons porteurs de kyste hydatique
- E- Contact par les mains avec le chien parasité

13. Le liquide hydatique est:

- A- Très riche en protoscolex
- B- Aseptique
- C- Faiblement antigénique
- D- Est l'élément responsable des réactions anaphylactiques liées au kyste hydatique
- E- À pH acide

14. Les aspects radiographiques d'un KHP rompu dans les bronches sont:

- A- Une image en « boulet de canon »
- B- Image de « pneumokyste »
- C- Un niveau hydroaérique
- D- Une image en grelot
- E- Une cavité isolée

15. Concernant le traitement chirurgical du kyste hydatique du poumon:

- A- La thoracotomie axillaire constitue la voie d'abord standard
- B- L'énucléation est indiquée pour les kystes non compliqués
- C- La kystectomie est indiquée pour les kystes pleins et de taille supérieure à 3cm.
- D- Le traitement du périkyte dépend du l'état du périkyte et du parenchyme adjacent
- E- La périkysectomie est contre-indiquée en cas de périkyte infecté

16. Chez un patient qui présente un cancer du rectum, héli circonférentiel et fixe au toucher rectal, bilan d'extension doit comporter :

- A. Un scanner thoraco abdomino pelvien.
- B. Un UroScanner.
- C. Une IRM pelvienne.
- D. Une scintigraphie osseuse.
- E. Une échographie endo-rectale

17. Un adénocarcinome du colon sigmoïde stade T3 N2 M0 est traité par :

- A. Une colectomie segmentaire basse et chimiothérapie adjuvante.
- B. Une héli colectomie droite.
- C. Une colectomie segmentaire haute et une chimiothérapie adjuvante.
- D. Une héli colectomie gauche vraie seule.
- E. Une colectomie sub- totale et une chimiothérapie néo-adjuvante.

18. La radio chimiothérapie est indiquée pour les cancers du rectum :

- A. Systématiquement quel que soit la localisation tumorale.
- B. Pour les tumeurs du 1/3 moyen et du 1/3 inférieur du rectum.
- C. Pour les tumeurs classées T1 sans métastases ganglionnaires.
- D. En cas d'atteinte ganglionnaire sur l'échographie endo-rectale ou à l'IRM pelvienne.
- E. Obligatoirement pour les tumeurs du 1/3 supérieur du rectum

19. Le dépistage des Cancers Colorectaux :

- A. Est justifiée pour la population à moyen risque.
- B. Est basé sur la recherche de sang dans les selles pour le patient à moyen risque.
- C. Est réalisé 5 ans avant l'âge du plus jeune cas familial dans le Syndrome de Lynch.
- D. Est basé sur le dosage des marqueurs tumoraux.
- E. A pour objectif de découvrir les lésions à un stade précoce comparativement aux sujets symptomatiques

20. L'artériographie coelio-mésentérique est utile chez un patient qui présente des melænas, à fin de déceler :

- A / des varices œsophagiennes,
- B / un saignement d'origine grêlique
- C / un ulcère hémorragique,
- D / un saignement non identifié à la coloscopie
- E / un saignement secondaire à une tumeur rectale

21. Au cours d'une hémorragie digestive haute, les signes prédictifs de la présence d'un saignement actif sont :

- A/La présence d'une rectorragie
- B/ Une anémie hypochrome microcytaire
- C/ Une déglobulisation au cours de la surveillance du patient
- D/Une tachycardie.
- E/.Une pression artérielle systolique à 70 mm hg

22. Au cours d'une hémorragie digestive haute, les signes en faveur d'un saignement secondaire à une complication de l'hypertension portale sont :

- A/ un foie bosselé, ferme avec une flèche hépatique à 16 cm
- B/ la présence d'un reflux hépato-jugulaire
- C/ Une hémorragie abondante
- D/La présence d'une circulation veineuse péri- ombilicale
- E/La présence d'un sub ictère conjonctival

23. le Volvulus :

- a) Correspond à l'incarcération d'une anse avec son méso dans un anneau fibreux
- b) Est responsable de distension intestinale avec risque de nécrose
- c) Intéresse un segment intestinal long et fixe
- d) Intéresse souvent le colon droit
- e) Ne peut pas intéresser l'intestin grêle

24. Au cours de l'OIA, les signes de souffrance intestinale sont :

- a) La fièvre
- b) L'hyperleucocytose supérieure à 15000 éléments/mm³
- c) La présence de pneumopéritoine à l'ASP
- d) La dilatation du cæcum à 9 cm
- e) Le rehaussement de la paroi intestinale à la TDM

25. Au cours des occlusions par strangulation :

- a) La vascularisation du segment intestinal occluse est compromise,
- b) L'évolution, en absence de traitement, se fait souvent vers le rétablissement spontané du transit
- c) L'occlusion est complète et irréversible
- d) Traitement est urgent et souvent chirurgical
- e) Le météorisme est mobile, animé d'ondulation péristaltique et gargouillant.

26. Concernant les tumeurs de l'œsophage :

- A- La dysphagie est souvent le symptôme révélateur.
- B- Elles peuvent être bénignes ou malignes.
- C- L'adénocarcinome est le cancer le plus fréquent.
- D- La FOGD avec biopsies permet de confirmer le diagnostic de carcinome épidermoïde de l'œsophage.
- F- La FOGD permet de poser le diagnostic de léiomyome.

27. Le diverticule de Zenker :

- A- Est un diverticule de pulsion.
- B- Se développe à partir de la paroi postérieure de l'œsophage.
- C- Se développe à partir de la paroi postérieure du pharynx.
- D- Est une cause de dysphagie pharyngée.
- E- Est une cause de dysphagie œsophagienne

28. Les TMO qui touchent le SIO sont :

- A- L'obstruction fonctionnelle du SIO.
- B- L'achalasie.
- C- L'œsophage marteau-piqueur.
- D- L'hypopéristaltisme œsophagien.
- E- Le spasme œsophagien.

29. Chez un patient tabagique, le diagnostic de BPCO peut être éliminé devant :

- A- Un VEMS post bronchodilatateur à 85% de la valeur prédite
- B- Un VEMS/CVF post bronchodilatateur à 75% de la prédite
- C- Une Capacité pulmonaire totale à 130 % de la prédite
- D- Une diffusion de CO (DLCO) à 30 % de la prédite
- E- Un VEMS/CVF avant la prise de bronchodilatateur à 73% de la prédite

30. La principale perturbation qui indique la VNI chez un patient porteur de BPCO en exacerbation aigue sévère est :

- A- Le trouble de la vigilance
- B- L'épuisement respiratoire
- C- L'hypoxémie sévère
- D- Le coma
- E- L'acidose respiratoire

31. Le traitement de fond des patients porteurs de BPCO peut comprendre :

- A- LAMA, LABA et Roflumilast
- B- LAMA, LABA et Azithromycine
- C- LAMA et LABA
- D- LAMA et corticothérapie inhalée
- E- Corticothérapie inhalée et Roflumilast

32. La réponse inflammatoire anormale dans les poumons se produit principalement dans:

- A- Les voies aériennes supérieures
- B- Les voies aériennes inférieures
- C- Parenchyme
- D- Système vasculaire pulmonaire
- E- Zones identifiées dans tout ce qui précède

33. Pendant l'expiration :

- A- La pression pleurale devient moins négative
- B- La pression alvéolaire atteint ses plus faibles valeurs
- C- Il y a une diminution du volume des poumons
- D- Le diaphragme est tiré vers le haut
- E- La pression abdominale devient moins négative

34. La phase d'état chez un patient adulte porteur de PFLA à pneumocoque se caractérise par la présence :

- A- d'un herpes naso-labiale
- B- d'une dyspnée intense quasi constante
- C- d'une fièvre élevée en plateau
- D- d'expectorations purulentes et abondantes
- E- de foyer de râles crepitants localisé

35. Concernant l'antibiothérapie initiale d'une pneumopathie infectieuse bactérienne :

- A- L'amoxicilline est indiquée d'emblée chez l'adulte jeune sans comorbidités porteur de pneumopathie alvéolaire traité en ambulatoire
- B- La clarithromycine est indiquée en cas de suspicion de pneumopathie à germe atypique
- C- L'amoxicilline acide clavulanique est indiquée en cas de pneumopathie à legionelle
- D- La levofloxacin en monothérapie est indiquée dans les formes graves de réanimation
- E- L'amoxicilline- acide clavulanique est indiquée en cas de pneumopathie alvéolaire chez un sujet âgé traité en ambulatoire

36. Les antibiotiques suivants sont habituellement actifs sur les PABC à pneumocoque :

- A- Levofloxacin
- B- Amoxicilline
- C- Pristinamycine
- D- Amikacin
- E- Amoxicilline-acide clavulanique

37. Une paracentèse est indiquée devant :

- A. Une otite moyenne aigue chez un nourrisson de 2 mois
- B. Une otite moyenne aigue compliquée de paralysie faciale périphérique
- C. Une Otite moyenne aigue chez un enfant immunodéprimé
- D. Un Syndrome otite-conjonctivite
- E. Une otite moyenne aigue collectée hyperalgique

38. Les facteurs de risque du cancer broncho-pulmonaire sont :

- A- L'exposition professionnelle à la silice
- B- Les lésions pulmonaires cicatricielles et fibreuses
- C- Les ATCDs familiaux de néoplasie
- D- Le déficit en $\alpha 1$ antitrypsine
- F- L'exposition aux pneumallergènes

39. Quelles sont parmi les manifestations suivantes, celles qui sont considérées comme paranéoplasiques :

- A. Un syndrome cave supérieur
- B. Une thrombocytose
- C. un syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH
- D. Une ostéopathie hypertrophique de Pierre Marie
- E. Une hypertension artérielle pulmonaire

40. Le PET scanner dans le bilan d'extension des cancers du poumon :

- A- est plus performant que le scanner pour préciser le stade N
- B- réalise un bilan à distance exhaustif
- C- est recommandé chez les patients opérables après analyse du TDM
- D- une lésion de moins de 10 mm peut être faussement non hypermétaboliques
- E- est utile à l'évaluation de la réponse à la chimiothérapie

41. Le traitement à visée curative d'un adénocarcinome primitif du poumon de 3 cm de diamètre du lobe supérieur droit avec adénopathies hilaires homolatérales sans métastases à distance est :

- A. Une lobectomie supérieure droite avec curage ganglionnaire
- B. Une chimiothérapie et radiothérapie thoracique
- C. Une radiothérapie thoracique
- D. Une curithérapie
- E. Une immunothérapie

42. Concernant la tuberculose pulmonaire commune, on retient :

- A- Une toux productive plus de trois semaines devra faire suspecter la tuberculose
- B- Le diagnostic se base essentiellement sur la mise en évidence du BK dans les expectorations
- C- L'examen physique pulmonaire est de grand apport dans le diagnostic positif
- D- Le polymorphisme radiologique est de règle
- F- La contagiosité est plus importante dans les formes nodulaires

43. Au cours du traitement de la tuberculose pulmonaire et selon le PNLT:

- A- la prise en charge est gratuite
- B- un bilan biologique de contrôle est systématique
- C- l'apparition de signes digestifs indique l'arrêt du traitement
- D- l'apparition d'une réaction cutanée allergique indique l'arrêt de tous les antituberculeux
- E- un contrôle radiologique se fait à 1 mois du traitement

44. La prévention vaccinale par le BCG :

- A. est obligatoire pour tous les nouveaux nés
- B. est obligatoire pour tout enfant ayant un déficit immunitaire
- C. est obligatoire pour tout professionnel de santé
- D. Protège contre les formes graves de tuberculose
- E. comporte un test préalable par IDR

45. Le protocole thérapeutique de la tuberculose pulmonaire non compliquée de l'enfant :

- A- 2HRZE/4HR
- B- 2HRZ/4HR
- C- 3HRZ/6HR
- D- 2HRZS/4HR
- E- 3HRE/4HR

46. Au cours du traitement de la tuberculose pulmonaire, la surveillance bactériologique selon le PNLT se fait à :

- A- 15 jours du traitement
- B- 2 mois du traitement
- C- 4 mois du traitement
- D- 5 mois du traitement
- E- 6 mois du traitement

47. Chez un patient présentant une diarrhée chronique, le diagnostic d'un syndrome de l'intestin irritable (troubles fonctionnels intestinaux) est évoqué devant :

- A- L'alternance avec des épisodes de constipation.
- B- L'aspect liquide non glairo-sanglant de la diarrhée.
- C- L'aggravation des symptômes dans les périodes de stress.
- D- L'apparition récente des symptômes.
- E- L'évolution intermittente des symptômes.

48. Chez un patient présentant une diarrhée chronique, le diagnostic d'une maladie de Crohn est évoqué devant :

- A- La présence d'une fistule anale
- B- L'aspect segmentaire des lésions endoscopiques à la coloscopie.
- C- Le caractère sanglant de la diarrhée
- D- L'atteinte inflammatoire pancolique à la coloscopie
- E- L'âge jeune du patient

49. Le diagnostic d'infection à *Helicobacter pylori* (HP) peut être fait par :

- A- La coproculture.
- B- La recherche de la toxine de la bactérie dans les selles.
- C- Les hémocultures.
- D- La sérologie.
- E- Le test respiratoire à l'urée (breath test).

50. Concernant l'ulcère gastrique associé à l'infection par HP :

- A- Le traitement d'éradication de HP se base en première intention sur la trithérapie : IPP + Amoxicilline + Clarithromycine.
- B- il peut se compliquer d'un ictère hémolytique.
- C- Le contrôle de l'éradication de HP est systématique.
- D- Le contrôle endoscopique n'est pas utile si le patient devient asymptomatique sous IPP.
- E- Le traitement par IPP est nécessaire pendant au moins 6 semaines.

51. Devant un patient présentant un ictère cholestatique avec cytolyse à 12 N vous évoquez :

- A- Une cholangite biliaire primitive.
- B- Une tumeur de la tête du pancréas
- C- Une stéatose hépatique.
- D- Un accident de migration lithiasique.
- E- Une hépatite aiguë virale.

52. Un ictère cholestatique associé à une anémie ferriprive fait évoquer en premier :

- A- Tumeur de la tête du pancréas
- B- Cholangiocarcinome
- C- Lithiase de la voie biliaire principale
- D- Ampullome vaterien
- E- Kyste hydatique rompu dans les voies biliaires.

53. Chez un patient ictérique, une origine hémolytique de l'ictère doit être évoquée devant l'association à :

- A- Une pâleur cutanéomuqueuse.
- B- Une fièvre.
- C- Une hépatomégalie.
- D- Des adénopathies périphériques.
- E- Une splénomégalie.

54. Un ictère cholestatique associé à un épisode de méléna peut être secondaire à :

- A- Un cholangiocarcinome du bas cholédoque.
- B- Un ampulome Vaterien.
- C- Une lithiase de la voie biliaire principale compliquée.
- D- Un kyste hydatique du foie compliqué
- E- Un cancer du corps du pancréas.

55. Pour évaluer la sévérité d'une hépatite virale aiguë on utilise le test suivant :

- A- Transaminases
- B- Bilirubine
- C- Phosphatases alcalines
- D- Gamma GT
- E- Taux de prothrombine.

56. L'hépatite virale B :

- A- Se transmet par voie sanguine
- B- Peut se révéler par un ictère
- C- Ne passe jamais à la chronicité.
- D- Peut donner un tableau d'hépatite aiguë grave
- E- La transmission mère-enfant est possible

57. La formation de micelles est nécessaire à l'absorption :

- A. du calcium
- B. des triglycérides
- C. des acides biliaires
- D. de la vitamine K
- E. de la vitamine B12

58. La résection d'un mètre de l'iléon distal peut entraîner une malabsorption :

- A. du fer
- B. du calcium
- C. des acides biliaires
- D. des acides aminés
- E. de la vitamine B12

59. L'absorption intestinale du fer est augmentée par:

- A. les acides biliaires
- B. la vitamine D
- C. la vitamine C
- D. l'hépcidine
- E. l'acidité gastrique

60. La sécrétion acide gastrique augmente sous l'effet de :

- A. l'acétylcholine
- B. l'histamine
- C. la sécrétine
- D. la somatostatine
- E. les prostaglandines

61. La sécrétion de gastrine augmente en réponse à :

- A. l'acétylcholine
- B. l'arrivée d'aliments riches en protéines
- C. l'histamine
- D. la distension de l'estomac
- E. la sécrétine

62. Au cours des conjonctivites aiguës

- A. L'acuité visuelle est souvent conservée
- B. Le test à la néosynéphrine est positif
- C. Le cercle périkératique est un signe spécifique
- D. La douleur est lancinante
- E. Le test à la fluorescéine est positif

63. Parmi les signes suivants associés à une rougeur oculaire, ceux qui témoignent de sa gravité

- A. Une baisse progressive de l'acuité visuelle
- B. Une rougeur prédominante au niveau des culs de sacs conjonctivaux
- C. Une semi-mydriase aréflétique
- D. Des céphalées récidivantes homolatérales, avec un brouillard visuel
- E. Une hernie de l'iris à travers une plaie cornéenne

64. Lors d'un traumatisme perforant du globe oculaire

- A. L'ophtalmie sympathique est une complication grave
- B. Un corps étranger intraoculaire doit être systématiquement éliminé
- C. Une échographie oculaire doit être réalisée en urgence
- D. La radiographie des orbites n'a plus de place.
- E. L'exploration chirurgicale n'est pas systématique

65. L'obsession est :

- A. Une idée délirante.
- B. Une sorte d'hallucination.
- C. L'intrusion dans la pensée d'une idée pathologique.
- D. Associée aux psychoses.
- E. Accompagnée d'une détresse/ souffrance psychologique

66. Le Trouble Stress Aigu :

- A. Survient à la suite de l'accumulation de plusieurs facteurs de stress
- B. S'accompagne d'une hypermnésie
- C. Se caractérise par une reviviscence traumatique diurne et/ou nocturne
- D. Evolue sur deux à trois mois
- E. Peut évoluer vers un Trouble Stress Post Traumatique

67. L'agoraphobie est :

- A. Une crise d'angoisse aiguë.
- B. Accompagnée d'idées obsédantes.
- C. Une complication du trouble panique
- D. Accompagnée de conduites d'évitement.
- E. Associée à des hallucinations auditives.

68. La douleur thoracique secondaire à une péricardite aigue :

- A) Est permanente
- B) Diminue en position penchée en avant
- C) augmente en inspiration profonde
- D) Est transfixiante
- E) Irradie vers les machoires

69. Les signes électriques évocateurs d'une péricardite aigue sont :

- A) Un sous décalage diffus du segment ST
- B) Un sous-décalage de PQ
- C) Un bloc de branche gauche
- D) Un microvoltage
- E) Une onde Q de pseudonécrose

70. Les complications possibles de la dissection aortique de type B sont :

- A) Une insuffisance aortique aigue
- B) Une endocardite infectieuse
- C) Un hémopéritoine
- D) Une ischémie aigue du membre inférieur
- E) Un AVC

71. Quels peuvent être les signes cliniques de l'endocardite infectieuse ?

- A) Une Insuffisance hépatique
- B) Une Apparition d'un souffle cardiaque
- C) Un Amaigrissement
- D) Une Fièvre prolongée
- E) Une Insuffisance cardiaque

72. La stimulation des barorécepteurs entraine :

- A. Une sécrétion d'ADH
- B. Une stimulation du noyau du tractus solitaire
- C. Une levée de l'inhibition du centre vasomoteur
- D. Une stimulation du noyau du vague
- E. Une augmentation de la fréquence de décharge des voies afférentes

73. Une sténose des artères rénales est suspectée en cas :

- A. D'HTA résistante
- B. D'auscultation d'un souffle lombaire
- C. D'antécédents de traumatisme lombaire
- D. De réninémie basse
- E. D'un tableau d'hyperaldostéronisme primaire

74. Une HTA peut être secondaire :

- A. A la Glycerrhizine (régliste)
- B. Aux oestro-progestatifs
- C. A certains psychotropes
- D. Aux vasoconstricteurs nasaux
- E. Aux statines

75. Vous avez décidé de prescrire une association de 2 antihypertenseurs chez un patient diabétique hypertendu. Parmi ces associations, lesquelles peuvent être indiquées en première intention ?

- A) Un inhibiteur de l'enzyme de conversion + un diurétique thiazidique
- B) Un inhibiteur calcique + un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II
- C) Un bêtabloquant + un diurétique thiazidique
- D) Un inhibiteur de l'enzyme de conversion + un inhibiteur calcique
- E) Un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II + un diurétique thiazidique

76. L'inter-ventriculaire antérieure :

- A) Chemine dans le sillon graisseux interventriculaire postérieur
- B) Vascularise la majeure partie des parois du ventricule gauche
- C) Vascularise le ventricule droit par une branche marginale
- D) Donne des branches diagonales et septales
- E) Se termine dans la partie inférieure du septum interventriculaire

77. Une plaque d'athérosclérose vulnérable est caractérisée par :

- A) Un noyau lipidique abondant
- B) Un noyau lipidique de croissance lente
- C) Un noyau lipidique riche en macrophages
- D) Une chape fibreuse fine
- E) Une chape fibreuse calcifiée

78. Les signes cliniques pouvant être compatibles avec le diagnostic de thrombophlébite des membres inférieurs sont :

- A- Une grosse jambe douloureuse
- B- Une douleur du mollet à la flexion du pied
- C- Une raréfaction des poils
- D- Une diminution de la sensibilité superficielle
- E- Une augmentation de la chaleur locale

79. Les signes échographiques en faveur d'une embolie pulmonaire sont :

- A- Une HTAP
- B- Une dilatation du VD
- C- Un septum interventriculaire paradoxal
- D- Une dysfonction systolique du VG
- E- Une dilatation de la VCI

80. Le traitement au long cours d'une embolie pulmonaire suite à une immobilisation plâtrée peut comporter :

- A- Les HBPM
- B- La warfarine
- C- L'acénocoumarol
- D- Le rivaroxaban
- E- L'apixaban

81. Le déclenchement des règles chez une femme qui prend des pilule normodosées:

- A. Est due aux hormones contenues dans la pilule combinée.
- B. Est due à l'arrêt de la prise de pilule.
- C. Est due à une augmentation des concentrations en œstrogène et progestérone.
- D. Correspond à une destruction de la muqueuse endométriale.
- E. est due à la prise de la pilule pendant 21 jours suivis de 7 jours d'arrêt.

82. La pilule du lendemain :

- A. Provoque un rétrocontrôle négatif puissant au niveau de l'hypothalamus et l'hypophyse.
- B. Déclenche les règles Correspond à une IVG
- C. Bloque la progression des spermatozoïdes
- D. Contient des œstrogènes et de la progestérone.
- E. contient une forte dose de progestérone

83. Le DIU hormonal:

- A. Est indiqué en cas de ménorragies
- B. Est indiqué en cas de dysménorrhée
- C. Est responsable d'une hypertrophie endométriale
- D. Est responsable d'une glaire fluide.
- E. Est responsable d'une réaction inflammatoire au niveau de l'endomètre

84. La progestérone peut être responsable de:

- A. Nausées et vomissements
- B. Acnés et séborrhées
- C. Hypertrichose
- D. Dichromies du visage
- E. Métorragies inter-menstruelles

85. Le cancer in situ du col utérin :

- A- Est plus fréquent chez la femme de plus de 50 ans
- B- Est strictement limité à la muqueuse.
- C- N'a aucune traduction clinique.
- D- Ne nécessite pas de bilan d'extension.
- E- Peut être traité par une conisation qui passe in sano.

86. Le dépistage du cancer du col utérin par frottis cervico-utérin exclut :

- A- Les femmes âgées de plus de 60 ans.
- B- Les vierges.
- C- Les femmes enceintes.
- D- Les femmes ayant eu une hystérectomie totale.
- E- Les femmes ayant reçu un vaccin anti HPV tétravalent à l'adolescence.

87. Dans le cadre du cancer du col utérin, la colposcopie :

- A- confirme le diagnostic
- B- est peu spécifique
- C- est inutile si la tumeur est visible à l'examen clinique
- D- peut être indiquée pour la surveillance à long terme en cas de traitement conservateur
- F- est très peu sensible

88. Chez une femme porteuse d'un DIU qui présente des métrorragies, les 2 premiers diagnostics à évoquer sont :

- a. Une salpingite
- b. Une fausse couche spontanée
- c. Une GEU
- d. Une hyperplasie de l'endomètre
- e. Un fibrome sous séreux

89. Les métrorragies en rapport avec un placenta prævia sont caractérisées par :

- A- L'aspect rouge vif
- B- La tendance à la récurrence
- C- L'absence de souffrance fœtale
- D- La douleur brutale associée
- E- Leur apparition typique au début du deuxième trimestre

90. Indiquez les 2 explorations préconisées de première intention chez une femme ménopausée depuis 5 ans qui présente des métrorragies évoluant depuis 3 mois :

- A- Une IRM pelvienne
- B- Une échographie endo-vaginale
- C- Une hystéroscopie avec biopsies dirigées
- D- Une TDM pelvienne
- E- Une hystérographie

91. La grossesse extra-utérine a une fréquence accrue dans la ou les circonstances suivantes :

- A. Antécédent de stérilité
- B. Antécédent de salpingite
- C. Antécédent d'avortement spontané du deuxième trimestre
- D. Contraception par oestro-progestatif normo-dosé
- E. Contraception par stérilet

92. On parle de grossesse extratubaire si la localisation de la grossesse est :

- A. Sur cicatrice
- B. Ampullaires
- C. Intra myométriales
- D. Sous hépatiques
- E. Cornuales

93. Le tableau de l'inondation par rupture cataclysmique de grossesse ectopique comporte :

- A. Douleurs scapulaires
- B. Douleur hypogastrique brutale
- C. Tachycardie
- D. Contracture abdominale
- E. Douleur du cul de sac de Douglas

II- Partie II : CCQCM

Cette partie comprend cas cliniques. Les réponses doivent être inscrites sur la grille réservée aux CCQCM

Cas Clinique 1:

Patient âgé de 53 ans, hypertendu depuis 4 ans, sous double antihypertenseur, consulte en urgence pour une lourdeur de l'hémicorps droit de survenue brutale. Sa famille raconte qu'au cours des deux derniers mois, il s'était plaint à plusieurs reprises d'un trouble visuel de l'œil gauche "comme un voile" disait-il, qui avait régressé à chaque fois en quelques minutes. L'examen neurologique montre : un léger ptosis avec myosis à gauche, une hémiplégie droite à prédominance brachio-faciale sans troubles sensitifs, une aphasie de Broca, une auscultation cervicale normale, un rythme cardiaque régulier et une tension artérielle à 16/11.

Vous portez le diagnostic d'un AVC ischémique.

1. Le territoire touché est :

- A. Fossette postérolatérale du bulbe gauche
- B. Sylvien superficiel antérieur gauche
- C. Sylvien superficiel postérieur gauche
- D. Sylvien superficiel antérieur et postérieur gauche
- E. Sylvien total gauche

2. Le ptosis léger avec myosis réactif gauche correspond à :

- A. Une paralysie de la IV^{ème} paire
- B. Une paralysie partielle de la III^{ème} paire
- C. Une paralysie partielle de la VI^{ème} paire
- D. Un syndrome de Claude Bernard Horner
- E. Une paralysie faciale centrale

3. Les troubles visuels régressifs antérieurs à l'infarctus évoquent en premier :

- A. Des épisodes d'hémianopsie latérale homonyme gauche
- B. Des épisodes d'amaurose gauche
- C. Des épisodes de cécité corticale gauche
- D. Des crises épileptiques focales visuelles
- E. Des poussées hypertensives

4. L'étiologie la plus probable à cet AVC est :

- A. L'Athérosclérose
- B. Une cardiopathie emboligène
- C. La dissection carotidienne
- D. Une vascularite cérébrale
- E. Indéterminée

5. Le diagnostic d'obstruction carotidienne au cou peut être conforté par :

- A. L'existence d'un souffle cervical sous angulo-maxillaire gauche
- B. L'échographie doppler cervicale
- C. Le scanner cérébral
- D. L'angioscanner des troncs supra-aortique
- E. Le fond d'œil

Cas Clinique 2:

Mademoiselle M, 15 ans, est adressée à votre consultation pour avis diagnostique et thérapeutique après une première crise généralisée motrice survenue hier matin au réveil. La description de la crise vous est faite avec précision par sa mère qui l'accompagne : elle a noté des mouvements arythmiques bilatéraux, des deux membres supérieurs puis la perte de connaissance, avec les manifestations tonico-cloniques.

L'interrogatoire vous apprend qu'il y a eu, ces derniers mois des « accidents » nocturnes (réveils dans des draps souillés d'urine, bosses sur le front, chute du lit). Toute la famille a remarqué sa « maladresse » qui occasionne des incidents au petit déjeuner : elle lâche brusquement sa tasse pleine par exemple.

L'examen neurologique est normal

6. Quel syndrome épileptique suggèrent à priori les éléments de l'observation ? justifiez ?

- a) Epilepsie myoclonique juvénile
- b) Epilepsie focale motrice
- c) Spasme épileptique
- d) épilepsie absence avec des automatismes
- e) épilepsie généralisée du réveil

7. Quel examen fondamental confirme ce diagnostic et quels en sont les résultats ?

- a) EEG qui note des pointes ondes généralisés
- b) IRM cérébrale à la recherche d'une lésion corticale
- c) Ponction lombaire
- d) Holter EEG
- e) Bilan de vascularite

8. Quel traitement de 1ère intention ?

- a) Carbamazepine
- b) Valproate de sodum
- c) léviteracetam
- d) Lamotrigine
- e) Phenobarbital

Cas Clinique 3 :

Patient âgé de 17 ans consulte pour douleurs de la FID évoluant depuis 5 jours avec vomissements pour lesquelles il prend un traitement non précisé, avec une aggravation depuis 24 heures, les douleurs sont devenues lancinantes et insomniantes. A l'examen T=40°C, TA=12/8, défense de la FID à la palpation. A la biologie GB = 18000 EB/mm³, CRP=150 mg/l.

9. Le tableau présenté par ce patient peut cadrer avec (une ou plusieurs réponses sont justes) :

- A- Une appendicite aiguë avec appendice perforé
- B- Un abcès appendiculaire
- C- Un plastron appendiculaire non compliqué
- D- Une tumeur caecale infectée
- E- Une appendicite aiguë non compliquée

10. L'examen de première intention dans ce cas est :

- A- Une échographie abdominale
- B- Un ASP
- C- Un scanner abdominal
- D- Une IRM abdominale
- E- Une coloscopie totale

Le patient refuse les soins et rentre chez lui. Il revient après 3 jours dans un état général altéré, il rapporte la généralisation des douleurs vers tout l'abdomen. A l'examen on trouve un faciès gris terreux, une $T = 40^{\circ}\text{C}$, $TA = 10/8$ mmHg, pouls = 100 bpm. Une contracture à l'examen de l'abdomen.

11. L'évolution du tableau présenté par le patient cadre avec (une ou plusieurs réponses est (sont) juste(s)) :

- A- Un plastron appendiculaire abcédé
- B- Une péritonite appendiculaire généralisée
- C- Une tumeur caecale perforée
- D- Une péritonite appendiculaire en 3 temps
- E- Un abcès appendiculaire rompu

Cas Clinique 4:

Patient âgé de 37 ans tabagique, consulte pour douleurs épigastriques d'installation brutale depuis 4 heures. A l'examen $T = 37,6^{\circ}\text{C}$, $TA = 11/8$, pouls = 88 bpm. Une défense abdominale généralisée. L'ASP centré sur les coupes diaphragmatiques est normal.

12. Le tableau clinique présenté par ce patient peut cadrer avec :

- A- Une péritonite aiguë par perforation d'ulcère gastro-duodénal
- B- Une crise hyperalgique d'ulcère
- C- Un ulcère perforé bouché
- D- Un abcès sous phrénique droit
- E- Une pancréatite aiguë

13. Le (les) examen(s) suivant(s) est (sont) utile(s) à la confirmation du diagnostic :

- A- Une échographie abdominale
- B- Une fibroscopie œsogastroduodénale
- C- Un scanner abdominal injecté
- D- Une lipasémie
- E- Un transit œsogastroduodénal

14. En fonction du diagnostic le plus probable, le traitement de ce patient comporte :

- A- Une antibiothérapie
- B- Une sonde nasogastrique en aspiration douce
- C- Des IPP en double dose
- D- Un antiémétique
- E- Une laparoscopie

Cas Clinique 5:

Un patient âgé de 31 ans, agriculteur, admis pour une douleur abdominale associé à une fièvre et urticaire. L'examen clinique a objectivé une TA à 90/50 mmHG, un pouls à 129 bpm et une défense abdominale généralisée.

Un scanner abdominal a montré une lésion kystique de 10 cm du segment V du foie avec un épanchement liquidien de grande abondance.

15. Quel est le premier diagnostic à évoquer ?

- A. Angiocholite aigue hydatique
- B. Péritonite aigue
- C. Pancréatite aigue
- D. Dissection de l'aorte
- E. Cholécystite aigue

16. Le mécanisme physiopathologie de cette complication est une :

- A. Ouverture de KHF dans les voix biliaires
- B. Rupture de kyste dans l'estomac
- C. Compression de la veine cave
- D. Rupture de kyste dans le péritoine
- E. Rupture de kyste dans la plèvre

17. La conduite thérapeutique en urgence consiste à :

- A. Une thoracotomie
- B. Une laparotomie médiane
- C. Une toilette abondante de la cavité péritonéale
- D. Une cholédocotomie et mise d'un drain de kher
- E. Une réanimation périopéraoire

Cas Clinique 6:

Une Femme âgée de 26ans, asthmatique depuis 8 ans, consulte pour dyspnée aigue d'installation brutale depuis 3h

A l'examen physique, T° : 37°C, Fr : 34 cycles/mn, Fc : 128b/mn, TA : 120/60 mm de hg, SaO₂ (AA): 88%, auscultation pulmonaire : des râles sibilants bilatéraux, peak flow 150 L/mn
GDS : pH : 7,48, PaO₂ : 58 mmHg, PaCO₂ : 28 mmhg, HCO₃⁻ : 20 mmol/l, SaO₂ : 89%

18. Quelles données orientant vers la gravité de la crise ?

- A- Fréquence respiratoire : 34 cycles/mn,
- B- Fréquence cardiaque : 128b/mn
- C- des râles sibilants bilatéraux
- D- l'ancienneté de l'asthme (8 ans)
- E- peak flow 150 L/mn

19. Votre conduite initiale serait :

- A- une hospitalisation
- B- une oxygénothérapie
- C- des corticoïdes systémiques
- D- la théophylline à la seringue électrique
- E- des nébulisations d'adrénaline

20. Après amélioration la spirométrie a été réalisée montrant un VEMS à 50%, un rapport à 65%, vous prescrivez à la sortie :

- A- β_2 mimétiques courte durée d'action
- B- Corticoïde inhalée + β_2 longue durée d'action
- C- Des nébulisations de corticoïdes à domicile
- D- Corticothérapie par voie orale pendant quelques jours
- E- Des anticholinergiques longue durée d'action

Cas clinique 7:

Un patient, âgé de 68 ans, tabagique 55 PA, porteur de BPCO a un score CAT évalué à 22 et une dyspnée d'effort évalué selon l'échelle mMRC à 2. L'anamnèse révèle la notion d'hospitalisation il y'a 8 mois pour une exacerbation infectieuse.

La spirométrie à l'état stable a objectivé un VEMS à 1,2L (38% de la valeur théorique), une capacité vitale forcée à 2,4L (54% de la valeur théorique).

Après 4 bouffées de Salbutamol, le VEMS passe à 1,3 L (41% de la valeur théorique) et la capacité vitale forcée passe à 2,6L (58% de la valeur théorique).

Gaz du sang à l'état stable contrôlé à 1 mois d'intervalle montre : PaO₂ : 75 mmHg, PaCO₂ : 42 mmHg, pH : 7,38. L'éosinophilie sanguine est à 125 éléments/mm³.

21. Selon la nouvelle classification de la BPCO, ce patient est classé :

- A- GOLD 2 groupe B
- B- GOLD 3 groupe C
- C- GOLD 2 groupe D
- D- GOLD 3 groupe B
- E- GOLD 3 groupe D

22. Le traitement de fond de la BPCO chez ce patient doit comporter :

- A- L'oxygénothérapie continue à domicile
- B- Traitement pharmacologique de 1ere intension par un LAMA.
- C- Traitement pharmacologique de 1ere intension par L'association LABA et LAMA.
- D- Traitement pharmacologique de 1ere intension par L'association LABA et corticothérapie inhalée.
- E- La réhabilitation respiratoire

L'évolution au cours du suivi est marquée par la persistance des exacerbations malgré la bonne adhésion au traitement et la bonne utilisation du système d'inhalation.

23. Quelle est le traitement pharmacologique de fond que vous proposez à ce patient dans ce cas?.

- A- Association LABA et corticothérapie inhalée
- B- Association LAMA et Roflumilast
- C- Association LABA,LAMA et antibiothérapie au long cours
- D- Association LABA , LAMA et Roflumilast
- E- Association LABA ,LAMA et corticothérapie inhalée

Cas clinique 8:

Homme âgé de 60 ans, tabagique à 40 PA, consulte pour névralgies cervico-brachiales gauche avec hémoptysie et dysphonie depuis 1 mois.

Examen: Hippocratisme digital

Rx Thorax: opacité apicale gauche rétractile avec lyse de la 1^{ère} et 2^{ème} cotes.

Fibroscopie bronchique: sténose de la lobaire sup gauche

Biopsie bronchique: un carcinome épidermoïde.

24. Les éléments en faveur du syndrome de pancoast tobias sont:

- A- les névralgies cervico-brachiales
- B- la dysphonie
- C- l'hippocratisme digital
- D- la lyse costale
- E- l'opacité apicale

25. Le bilan d'extension initial pour ce patient comporte:

- A- un scanner thoracique
- B- un scanner abdominal
- C- une échographie cervicale
- D- une IRM cérébrale
- E- un PET scanner

26. Le bilan a conclu à un stade IVB, la PEC thérapeutique pour ce patient comprend:

- A- une radiothérapie thoracique
- B- une chimiothérapie
- C- une association chimio-radiothérapie
- D- une chimiothérapie suivie d'une chirurgie
- E- une thérapie ciblée

Cas clinique 9:

Une femme âgée de 30 ans, enceinte au 6ème mois, sans antécédents pathologiques, est hospitalisée pour tuberculose pulmonaire commune.

27. Le bilan pré thérapeutique comprend:

- A- Un bilan hépatique
- B- Un examen ORL
- C- Un champs visuel
- D- Une vision de couleur
- E- Une IDR à la tuberculine

28. Le protocole thérapeutique pour cette patient est:

- A- 4HRZS/ 2HR
- B- 2HRZE/4HR
- C- 3HRE/6HR
- D- 4HRZ/2HR
- E- 2HRE/4HR

29. L'enquête dans l'entourage de la patiente trouve une intradermo-réaction (IDR) à la tuberculine à 15 mm chez son enfant âgé de 6 ans qui est asymptomatique. Cet enfant présente :

- A- Une tuberculose pulmonaire commune
- B- Une primo-infection tuberculeuse latente
- C- Une primo-infection tuberculeuse patente
- D- Une miliaire tuberculeuse
- E- Est indemne de toute infection tuberculeuse

Cas clinique 10:

Patient âgé de 5 ans, sans antécédents pathologiques notables consulte aux urgences pour œdème palpébral droit dans un contexte fébrile. L'examen physique note une exophtalmie avec chémosis. L'endoscopie nasale a objectivé du pus au niveau du méat moyen droit.

Le diagnostic d'une éthmoidite aigue extériorisée a été suspecté.

30. Le(s) examen(s) complémentaire(s) à demander est (sont):

- A. Des prélèvements bactériologiques du pus nasal
- B. Un bilan infectieux
- C. Une IRM cérébrale
- D. Une TDM des sinus et cérébrale injectée
- E. Une échographie des parties molles

L'examen que vous avez demandé a objectivé une éthmoidite aigue compliquée d'une cellulite orbitaire.

31. Votre conduite thérapeutique doit comporter :

- A. Amoxicilline-Acide Clavulanique per os
- B. Association de Céfotaxime + Fosfomycine
- C. Une héparinothérapie
- D. Des anti-inflammatoires non stéroïdiens
- E. Une désinfection rhinopharyngée

Après de 48 heures de traitement, Votre patient présente une aggravation de son exophtalmie avec limitation de l'abduction de l'œil droit et majoration des signes inflammatoires.

32. Les indications du traitement chirurgical chez ce patient sont :

- A. Le chémosis
- B. La limitation du mouvement d'abduction
- C. La majoration des signes inflammatoires
- D. L'aggravation de l'exophtalmie
- E. L'absence d'une collection

Cas clinique 11:

Patient âgé de 15 ans, originaire de Gafsa, sans antécédents pathologiques notables consulte pour une épistaxis récidivante gauche associée à une voix nasonnée évoluant depuis une année. Le patient rapporte récemment une hypoacousie avec autophonie récentes. L'examen physique montre un magma d'adénopathies spinales hautes gauches de 6 cm et un trismus. Une endoscopie nasale avec biopsie du cavum ont conclu à un UCNT du cavum.

33. Les signes cliniques qui plaident en faveur du diagnostic chez ce patient sont :

- A. L'origine géographique
- B. L'épistaxis unilatérale récidivante
- C. La voix nasonnée
- D. Le trismus
- E. L'autophonie

Une TDM du cavum réalisée a montré un processus tumoral comblant le nasopharynx s'étendant à l'oropharynx, infiltrant l'espace para pharyngé gauche, le muscle ptérygoïdien latéral et lysant l'apophyse ptérygoïde homolatérale, avec présence d'adénopathies rétro pharyngées bilatérales.

34. Ce bilan d'extension doit être complété par :

- A. Une IRM du cavum
- B. Une TDM thoraco abdomino pelvienne
- C. Une pan endoscopie
- D. Une scintigraphie osseuse
- E. Une échographie cervicale

Sachant que le bilan d'extension à distance que vous avez demandé n'a pas montré des métastases secondaires.

35. La tumeur sera classée selon la classification TNM de l'UICC 2017 en :

- A. T2N2M0
- B. T3N2M0
- C. T3N1M0
- D. T4N1M0
- E. T4N2M0

36. La prise en charge que vous préconisez chez ce patient comporte :

- A. Une Chimiothérapie néoadjuvante suivie de radio chimiothérapie concomitante
- B. Une radio chimiothérapie concomitante
- C. Une évaluation de l'état nutritionnel
- D. Une consultation d'oncofertilité
- E. La confection de gouttière porte gel fluoré

Cas clinique 12:

Patient âgé de 18 ans, suivi pour asthme allergique, consulte pour dysphagie aux solides, sans retentissement sur l'état général. L'interrogatoire révèle la notion d'épisodes d'impaction alimentaire.

37. Quel est le diagnostic le plus probable :

- A- Une œsophagite à éosinophiles.
- B- Une œsophagite virale.
- C- Une sténose caustique.
- D- Une achalasie.
- E- Un syndrome de Plummer Vinson.

38. En faveur de ce diagnostic on retient :

- A- Le sexe masculin.
- B- L'âge jeune.
- C- Le terrain atopique.
- D- L'absence de retentissement sur l'état général.
- E- L'antécédent d'impaction alimentaire.

39. Quels sont les signes endoscopiques en faveur de ce diagnostic :

- A- La présence d'ulcérations œsophagiennes.
- B- Le signe de ressaut.
- C- Un aspect pseudo-trachéal.
- D- La présence de sillons longitudinaux.
- E- La présence de dépôts blanchâtres.

Cas clinique 13:

Patient âgé de 67 ans, agriculteur, diabétique ayant des antécédents de syndrome dépressif sous antidépresseur tricyclique au long court. Il consulte pour une baisse brutale de vision de l'œil gauche, accompagnée de douleur, nausées et vomissements depuis trois jours. L'examen ophtalmologique trouve une acuité visuelle de 2/10 à droite et voit bouger la main à gauche, un tonus oculaire de 24 mmHg à droite et 50 mmHg à gauche, une semi mydriase aréfléctique gauche, une cataracte dense à droite et blanche totale à gauche. A la gonioscopie, l'angle irido-cornéen est ouvert et large à droite et fermé sur 360° à gauche. L'examen du fond d'œil est normal à l'œil droit et inaccessible à l'œil gauche.

40. Parmi les signes de l'examen ophtalmologique, ceux en faveur d'une crise aiguë de glaucome de l'œil gauche

- A. L'acuité visuelle limitée à voir bouger la main
- B. L'angle fermé sur 360°
- C. La semi mydriase aréfléctique
- D. La cataracte blanche totale
- E. Le fond d'œil inaccessible

41. Parmi les facteurs déclenchants de la crise aiguë de glaucome chez ce patient

- A. Diabète
- B. Prise d'antidépresseur au long court
- C. Exposition prolongée au soleil
- D. Profession comme agriculteur
- E. Effort continu

42. La prise en charge thérapeutique de ce patient indique

- A. Une hospitalisation urgente
- B. Un traitement chirurgical par phacoexérèse
- C. Une iridotomie périphérique préventive au laser à gauche
- D. Une iridotomie périphérique curative au laser à droite
- E. Une perfusion de Mannitol après bilan rénal normal

Cas clinique 14 :

Patiente de 27 ans, se plaint depuis 2 semaines d'asthénie intense avec ictère.

A l'interrogatoire on note une anorexie, une somnolence, des vomissements post-prandiaux et des polyarthralgies. La patiente rapporte qu'elle est toxicomane et qu'elle n'a pas eu de vaccination contre l'hépatite virale B.

A l'examen physique on note un score de Glasgow à 15/15, un ictère cutanéomuqueux franc et une hépatomégalie de 14 cm, ferme et à bord inférieur mou.

Vous évoquez le diagnostic d'hépatite virale aiguë.

43. Vous retenir comme signe(s) clinique(s) évoquant une hépatite grave chez cette patiente :

- A- L'asthénie.
- B- La somnolence.
- C- Les polyarthralgies.
- D- Les vomissements.
- E- L'hépatomégalie.

44. L'examen biologique qui permet d'évaluer la gravité de l'hépatite aiguë chez cette patiente est:

- A- Taux des transaminases sériques.
- B- Taux de prothrombine.
- C- Taux des plaquettes.
- D- Taux de bilirubinémie
- E- Taux d'hémoglobine.

45. Le diagnostic d'hépatite aiguë grave est porté chez cette femme. Quelle recherche doit être positive pour rapporter au virus B cette hépatite aiguë ?

- A- Recherche de l'antigène HBe.
- B- Recherche d'anticorps anti-HBc de type IgM.
- C- Recherche de l'antigène HBc.
- D- Recherche d'anticorps anti-HBe.
- E- Recherche d'anticorps anti-HBs.

46. L'évolution ultérieure de cette hépatite B peut être émaillée de(s) complication(s) suivante(s) :

- A- L'insuffisance rénale.
- B- Le carcinome hépato-cellulaire.
- C- Le lymphome hépatique.
- D- La cirrhose du foie.
- E- Neuropathie périphérique.

47. Dans le cadre de l'enquête familiale, une sérologie B a été pratiquée chez le mari de la patiente et a montré les résultats suivants : AgHBs (-), Ac anti-HBs (+), Ac anti-HBc type IgM (-), Ac anti-HBc type IgG (-), AgHbe (-) , Ac anti-HBe (-).

Le profil sérologique B du mari vous évoque une des hypothèses suivantes :

- A- Hépatite B chronique non replicative.
- B- Hépatite B occulte.
- C- Hépatite B chronique répliquative.
- D- Hépatite B ancienne immunisée.
- E- Sujet vacciné contre le virus B.

Cas clinique 15 :

Une femme de 32 ans consulte pour un syndrome anémique et une diarrhée chronique liquidienne. L'examen clinique montre une pâleur cutanéomuqueuse. La biologie montre une anémie hypochrome microcytaire à 9g/dl avec ferritinémie basse. La fibroscopie œsogastroduodénale est normale. Les biopsies duodénales montrent une augmentation des lymphocytes intra épithéliaux >30%, une hyperplasie des cryptes et une atrophie villositaire subtotale.

Vous évoquez le diagnostic d'une maladie cœliaque

48. Pour conforter votre diagnostic vous demandez :

- A- Dosage du facteur extrinsèque
- B- Dosage des anticorps anti-cellules duodénales
- C- Electrophorèse des protéines
- D- Dosage des anticorps anti-transglutaminase
- E- Dosage des anticorps anti-nucléaires.

49. Le traitement que vous proposez chez cette patiente est :

- A- Corticothérapie
- B- Traitement immunosuppresseur
- C- Traitement par immunoglobulines spécifiques
- D- Régime sans gluten
- E- Régime sans résidus

50. En cas de mauvaise observance du traitement, cette patiente sera exposée aux complications suivantes :

- A- Cavitation ganglionnaire.
- B- Lymphome intestinal
- C- Cancer gastrique
- D- Ostéopénie
- E- Hypersplénisme

Cas clinique 16 :

Mr. M.L âgé de 55 ans, tabagique et alcoolique, consulte pour un ictère progressif évoluant depuis 1 mois.

L'interrogatoire rapporte une anorexie, une perte de poids de 12 Kg en 3 mois, une diarrhée grasseuse, des douleurs de l'hypochondre droit, un prurit généralisé et des urines foncées.

L'examen physique du patient objective un ictère conjonctival franc, une pâleur cutanéomuqueuse, une hépatomégalie de 15 cm de consistance ferme, des lésions de grattage, une vésicule biliaire palpable et une adénopathie sus-claviculaire gauche de 2 cm indurée.

Le bilan biologique est comme suit : Bilirubine totale = 220 μmol ; Bilirubine directe = 180 μmol ; Phosphatase alcaline = 580 UI ; GGT = 450 UI ; ALAT = 31 ; ASAT = 36 ; glycémie = 12,6 mmol/L ; Hb = 8.4 g/dl ; GB = 5000, Plaquettes = 390000 ; TP = 62 % , Facteur V = 92%, urée= 4.5 mmol/L, créatininémie= 145 $\mu\text{mol/L}$.

On évoque un cancer de la tête du pancréas.

51. Parmi les données de l'anamnèse, vous retenir en faveur de votre diagnostic :

- A- Ictère progressif.
- B- Tabagisme actif.
- C- Diarrhée grasseuse.
- D- Amaigrissement.
- E- Prurit généralisé.

52. Parmi les données de l'examen physique, vous retenir en faveur de votre diagnostic :

- A- Lésions de grattage.
- B- Vésicule biliaire palpable.
- C- Hépatomégalie ferme.
- D- Adénopathie sus-claviculaire indurée.
- E- Pâleur cutanéomuqueuse.

53. Parmi ces éléments paracliniques, vous retenir en faveur de votre diagnostic :

- A- Baisse du taux de prothrombine (TP).
- B- Anémie.
- C- Cholestase biologique.
- D- Elévation de la créatininémie
- E- Hyperglycémie à jeun

54. Pour étayer votre diagnostic, vous demandez en premier ?

- A- Une IRM pancréatique.
- B- Une TDM pancréatique.
- C- Une échocoscopie bilio-pancréatique.
- D- Un dosage des enzymes pancréatiques
- E-. Un dosage sérique des CA 19-9.

55. Chez votre patient, vous retenir comme élément(s) de mauvais pronostic :

- A- L'hépatomégalie.
- B- L'amaigrissement.
- C- L'adénopathie sus-claviculaire gauche.
- D- L'insuffisance rénale.
- E- L'anémie.

Cas clinique 17 :

Mme S, 40 ans, consulte pour un mal-être profond. Elle se sent découragée, incapable de remplir ses fonctions de secrétaire d'administration. Elle se plaint d'avoir l'esprit flou, de ne pas pouvoir fixer son esprit. Elle oublie tout si elle ne note pas les tâches à réaliser. Elle n'arrive plus à finir son travail et les dossiers s'entassent sur son bureau. Elle n'a aucune envie, aucun plaisir et ne peut plus s'occuper des études de ses enfants. Elle souffre de troubles digestifs difficiles à décrire. Certains jours, elle ne peut pas s'alimenter. Elle pense parfois qu'elle a un cancer, puisque son estomac ne digère plus rien. Elle se demande même si elle n'est pas incurable. Au fond, elle souhaite presque joindre son mari, décédé il y a quatre ans, ajoutant que la vie n'a aucun intérêt sans lui.

56. Cette patiente présente :

- A. Une désorientation spatiale
- B. Un ralentissement psychique
- C. Des obsessions idéiques
- D. Une euphorie
- E. Un désir de mort

57. Le diagnostic syndromique comporte :

- A. Un syndrome dépressif
- B. Un syndrome démentiel
- C. Un syndrome confusionnel
- D. Une somatisation hystérique
- E. Un syndrome d'automatisme mental

58. Les parents de la patiente révèlent qu'elle a déjà souffert d'un état identique, il y a 12 ans. Un an après la mort de son mari, elle a été hospitalisée pour état d'excitation psychomotrice avec labilité de l'humeur. Vous évoquez le diagnostic de :

- A. Un trouble schizo-affectif
- B. Un trouble dépressif récurrent
- C. Une hypochondrie délirante
- D. Un trouble bipolaire
- E. Un trouble délirant paranoïaque

59. Le traitement préventif de cette pathologie doit comporter des :

- A. Antidépresseurs seuls
- B. Anxiolytiques seuls
- C. Antiparkinsoniens
- D. Thymorégulateurs
- E. Hypnotiques seuls

Cas clinique 18:

Madame B, âgée de 34 ans, rapporte qu'elle est hantée par la peur d'être contaminée par les microbes et les maladies et ceci depuis plusieurs mois.

Elle est en permanence assiégée par des idées récurrentes et persistantes de contaminations, idées qu'elle reconnaît être les siennes, mais qu'elle trouve absurdes et inappropriées ; En réponse à ces idées elle se trouve obligée de se laver les mains plusieurs fois afin de diminuer l'angoisse d'être contaminée ; Elle se sent épuisée et elle a des problèmes au travail à causes des retards répétitifs.

La relation de madame B avec son mari s'est détériorée ces derniers mois, il lui reproche de ne pas lui accorder l'attention qu'il mérite du fait qu'elle passe tout son temps à nettoyer toute la maison.

60. De point de vue sémiologique, que retenir-vous chez B?

- A. Idées de suicide altruiste
- B. Phobie d'impulsion
- C. Obsessions phobiques
- D. compulsion de lavage
- E. Arithmomanie

61. Quel(s) est (sont) le(s)diagnostic(s) à retenir devant ce tableau clinique ?

- A. Dépression mélancolique avec obsessions impulsives
- B. Trouble obsessionnel compulsif
- C. Début de schizophrénie
- D. Dépression chez une personnalité obsessionnelle
- E. Trouble panique avec agoraphobie

62. Quelle(s) complication(s) sont à redouter devant ce tableau clinique ?

- A. Un trouble de stress post traumatique
- B. Un épisode dépressif
- C. Un trouble Bipolaire de l'humeur
- D. Un trouble anxiété généralisée
- E. Une conduite suicidaire

Cas clinique 19:

Monsieur C., 45 ans, sans antécédents psychiatriques, est hospitalisé pour des troubles du comportement rapidement installés depuis 36 heures. Il a du mal à tenir en place, parle beaucoup, dort peu. Il semble par moments très perplexe, comprenant mal les propos du médecin : il se trompe sur la date, se croit à son travail, oublie au fur et à mesure ce qu'on lui dit paraît légèrement somnoler par instants, à d'autres, semble très inquiet, "où suis-je ? Qui êtes vous ?", demande-t il aux personnes présentes. Brusquement, il jette un objet dans un coin de la pièce comme pour se défendre d'une vision terrifiante.

L'examen clinique est normal, mis à part une fièvre à 38,5 degrés et des signes de déshydratation (soif, langue sèche, ébauche de pli cutané).

L'examen neurologique est normal

63. Parmi la liste de symptômes suivants, quel est celui ou quels sont ceux qu'on retrouve dans cette observation ?

- A. Désorganisation de la pensée
- B. Exaltation thymique
- C. Perplexité anxieuse
- D. Automatisme mental
- E. Désorientation temporo-spatiale

64. Quel(s) diagnostic(s) peut-on évoquer en priorité ?

- A. Accès maniaque
- B. Délire paranoïaque
- C. Schizophrénie
- D. Confusion mentale
- E. Dépression délirante

65. Quelle est la ou quelles sont les mesures thérapeutiques qui s'imposent dans l'immédiat ?

- A. Hospitalisation
- B. électro-convulsivo thérapie (ECT)
- C. Contention Physique
- D. Prescription de benzodiazépines
- E. Réhydratation

Cas clinique 20:

Un patient âgé de 60 ans, hypertendu, consulte aux urgences pour une douleur thoracique transfixiante, permanente, d'installation brutale et irradiante vers le dos.

L'examen physique met en évidence une pression artérielle à 220/100 mmHg au bras droit et 120/70 mmHg au bras gauche, l'auscultation cardio-pulmonaire ainsi que l'électrocardiogramme sont normaux.

66. A ce stade de l'examen, quel est le diagnostic le plus probable ?

- A) Une dissection aortique
- B) Une embolie pulmonaire
- C) Un pneumothorax
- D) Une pancréatite aiguë
- E) Un syndrome coronarien aigu

67. Quelle est le niveau de probabilité du diagnostic que vous avez évoqué ?

- A) Faible
- B) Très faible
- C) Intermédiaire
- D) Forte
- E) Modérée

68. Quel examen demandez-vous de première intention pour confirmer votre diagnostic ?

- A) Un angioscanner aortique
- B) Un angioscanner thoracique
- C) Une échographie cardiaque trans-thoracique
- D) Une échographie cardiaque trans-oesophagienne
- E) Une radiographie de thorax

Cas clinique 21:

Un patient âgé de 65 ans, diabétique sous ADO, sans autres facteurs de risque cardiovasculaire connus, consulte pour des céphalées occipitales.

L'examen somatique est sans particularités en dehors d'une pression artérielle à 170/95 mmHg.

69. Quel est le niveau de risque cardiovasculaire global chez ce patient ?

- A) Faible
- B) Modéré
- C) Moyen
- D) Élevé
- E) Très élevé

70. Vous demandez systématiquement chez ce patient:

- A) Un bilan hépatique
- B) Un scanner cérébral
- C) Un fond d'œil
- D) Une NFS
- E) Une échographie cardiaque

71. Votre prise en charge chez ce patient comportera :

- A) Des règles hygiéno-diététiques (RHD) seules
- B) Des règles hygiéno-diététiques avec une monothérapie par un IEC
- C) Un régime sans sel
- D) Une bithérapie comportant un IEC et un inhibiteur calcique avec des RHD
- E) Une trithérapie comportant un IEC, un inhibiteur calcique et un thiazidique

Cas clinique 22 :

Une patiente âgée de 56 ans, hypertendue et diabétique, consulte pour douleur thoracique évoluant depuis 3 heures avec survenue d'un épisode de perte de connaissance.

L'examen trouve une patiente algique, une TA à 140/80 bpm et une FC à 35 bpm.

L'auscultation cardio-pulmonaire est normale.

L'ECG montre une dissociation auriculo-ventriculaire complète avec un sus décalage de ST en DII DIII AVF et un sous décalage de ST en V1V2V3.

72. Quel est votre diagnostic ?

- A) SCA ST+ inférieur compliqué de BAV complet
- B) SCA ST+ inférieur compliqué de tachycardie ventriculaire
- C) SCA ST+ inférieur étendu au VD
- D) SCA ST+ inférieur compliqué de fibrillation auriculaire
- E) SCA ST+ inférieur compliqué d'insuffisance mitrale aigue

73. Quelle serait l'artère coupable à votre avis?

- A) La circonflexe
- B) L'IVA
- C) La diagonale
- D) La coronaire droite
- E) Le tronc commun

74. Quelle serait votre conduite thérapeutique en urgence?

- A) Un choc électrique externe
- B) Amiodarone 300 mg en iv
- C) Atropine en iv
- D) Une angioplastie primaire
- E) Massage cardiaque externe